틀니(의치) 동의서

가철성 보철 — 완전틀니, 부분틀니, 즉시틀니, 임플란트 지지 틀니

틀니 치료 종류 (해당 항목 표시)

☐ 상악 완전틀니 (위턱 전체 틀니)

☐ 하악 완전틀니 (아래턱 전체 틀니)

☐ 상악 부분틀니 ☐ 하악 부분틀니

☐ 즉시틀니 (발치 당일 장착)

☐ 임플란트 지지 틀니 / 오버덴쳐

☐ 기존 틀니 릴라인(이장) / 리베이스(개상) / 수리

틀니 치료의 성격

틀니(의치)는 상실된 자연 치아와 주변 조직을 대체하는 가철성(착탈식) 보철 장치입니다. 완전틀니는 한쪽 턱 전체의 치아를 대체하고, 부분틀니는 일부 상실 치아를 대체하며 남아 있는 자연 치아에 클래스프(고리) 또는 어태치먼트로 고정됩니다. 즉시틀니는 남은 치아를 발치하는 당일에 장착되어 치유 보조 및 임시 보철 역할을 합니다. 임플란트 지지 틀니(오버덴쳐)는 외과적으로 식립한 임플란트에 의해 안정됩니다.

틀니 제작은 일반적으로 약 4~8주에 걸쳐 여러 차례의 내원(인상채득, 교합채득, 왁스 시적, 장착, 장착 후 조정)이 필요합니다. 틀니는 영구적 보철물이 아니며, 정상적 마모와 구강 조직의 변화로 인해 시간이 지남에 따라 주기적인 관리, 릴라인(이장), 리베이스(개상), 수리 또는 재제작이 필요합니다.

틀니 치료의 대안

임상적으로 적절한 범위 내에서 다음과 같은 대안을 설명받았습니다:

- 치료하지 않음 (이 경우 추가 치아 상실, 골 흡수, 남은 치아의 이동, 안모 변화, 저작 기능 점진적 저하가 발생할 수 있음)
- 인접 자연 치아를 지대치로 하는 고정성 브릿지
- 개별 크라운 또는 고정성 임플란트 브릿지를 포함한 임플란트 치료

- 임플란트 유지 / 임플란트 지지 오버덴쳐 (일반 틀니 대비 유지력·안정성 향상)

각 대안의 위험, 이점, 대략적 비용 및 적응증에 대해 상의하였으며, 위에 표시된 틀니 치료를 선택합니다.

위험 및 가능한 합병증

다음 위험과 합병증을 이해하며, 이 중 일부는 가철성 보철물 착용에 본질적으로 수반되는 것으로 의사의 술기나 재료의 품질과 무관하게 완전히 제거할 수 없음을 이해합니다:

1. **적응 기간:** 새 틀니는 입 안에서 이물감이 느껴집니다. 수 주에서 수 개월의 적응 기간이 정상적이며 예상되는 과정입니다. 이 기간 중 침 증가, 발음 변화(특히 혀짤배기 발음), 충만감, 미각 변화, 저작 곤란을 경험할 수 있습니다. 개인의 적응도는 매우 다양하며 사전에 예측할 수 없습니다.
2. **욕창(Sore Spot) 및 궤양:** 대부분의 환자에서 틀니가 연조직을 압박하는 부위에 욕창이 발생합니다. 여러 차례의 조정 내원은 정상이며 틀니 장착 과정의 일부로 간주됩니다. 조정을 위한 재내원을 하지 않을 경우 지속적 궤양, 조직 손상, 또는 구강 전암성 병변까지 초래할 수 있습니다.
3. **골흡수 (턱뼈 수축):** 치아 상실 후 하부 골조직과 잇몸 조직은 시간이 지남에 따라 점진적·영구적으로 수축합니다. 이는 어떤 틀니로도 예방하거나 되돌릴 수 없는 생물학적 과정입니다. 골흡수는 결국 잘 만든 틀니도 느슨해지게 만들어, 추가 비용이 발생하는 릴라인·리베이스·재제작이 필요하게 됩니다.
4. **유지력 저하 및 틀니 접착제 필요성:** 시간이 지남에 따라, 특히 하악 완전틀니의 경우, 하부 골 흡수로 인해 틀니가 느슨해질 수 있습니다. 틀니 접착제가 필요할 수 있습니다. 특히 하악 완전틀니의 경우 자연 치아에 필적하는 편안하고 흡착된 유지력은 보장되지 않습니다.
5. **저작 효율 저하:** 틀니 착용 시 저작 효율은 일반적으로 자연 치아의 20~25% 수준입니다. 단단하거나 끈적이거나 질긴 음식 중 일부는 섭취가 어렵거나 불가능할 수 있습니다. 틀니가 자연 치아처럼 기능할 것이라고 기대해서는 안 됩니다.
6. **구역 반사 (Gag Reflex):** 상악 틀니는 입천장을 덮으므로 예민한 환자에서 구역 반사를 유발할 수 있습니다. 대부분 수 주 내에 적응하나, 소수의 환자는 일반 상악 틀니를 견디지 못해 대체 치료가 필요할 수 있습니다.
7. **발음 변화:** 특정 발음(특히 's', 'f', 'v', 'th' 등)이 일시적 또는 영구적으로 변할 수 있습니다. 연습과 적응으로 대개 해결되나, 일부 잔여 발음 변화가 지속될 수 있습니다.
8. **파절, 파손 및 마모:** 틀니는 떨어뜨리거나 과도한 저작력이 가해지면 금이 가거나 파절될 수 있습니다. 인공치아는 시간이 지나며 마모되어 교체가 필요할 수 있습니다. 취급 부주의로 인한 파손은 환자 본인의 책임입니다.

9. 심미성 한계: 자연스러운 외관을 위해 최선을 다하나, 치아 색조·형태·배열은 해부학적·기능적 한계 내에서 결정됩니다. 환자는 왁스 시적 단계에서 심미성을 승인할 기회를 가지며, 최종 완성 후 요청되는 변경은 재제작 없이는 불가할 수 있고 추가 비용이 발생할 수 있습니다.

10. 남은 자연치에 미치는 영향 (부분틀니): 부분틀니는 클래스프와 레스트를 통해 남은 자연 치아에 추가적인 힘을 가합니다. 이는 장기적으로 치아 동요, 충치, 잇몸 퇴축, 또는 지대치 상실의 위험을 증가시킬 수 있습니다. 철저한 구강 위생 관리가 필수적입니다.

11. 알레르기 반응: 틀니 재료(레진, 단량체, 금속 합금)에 대한 드문 알레르기 반응이 보고되었습니다. 알고 있는 모든 알레르기는 병력에 고지하였습니다.

12. 의치성 구내염 및 진균 감염: 틀니를 계속 착용하는 경우 — 특히 야간 — 진균 감염(칸디다증)과 조직 염증 위험이 증가합니다. 틀니는 야간에 제거하여 조직이 쉴 수 있도록 해야 합니다.

13. 안모 변화: 틀니는 입술과 볼을 지지하여 안모에 영향을 줍니다. 초기에는 예상보다 '꽉 찬' 느낌이나 다른 외관이 될 수 있으며, 이는 적응과 함께 개선됩니다.

14. 턱관절(TMJ) 불편감: 교합의 변화로 턱관절이나 저작근에 일시적 불편감이 발생할 수 있습니다. 지속되는 불편감은 교합 조정을 위해 반드시 보고해야 합니다.

위 목록은 모든 위험을 망라한 것이 아니며, 다른 드문 합병증이 발생할 수 있습니다. 이러한 위험 및 기타 사항에 대해 질문할 충분한 기회를 가졌습니다.

특별 고지 — 즉시틀니 (해당 시)

즉시틀니(남은 치아 발치 당일 장착)로 치료받는 경우, 다음 사항을 특별히 이해하고 동의합니다:

- 즉시틀니는 발치 전에 제작되므로, 발치 전에는 최종적인 심미 결과와 구강 내 적합도를 확인할 수 없습니다.
- 발치 후 3~6개월의 치유 기간 동안 상당한 잇몸 및 골의 수축이 반드시 발생합니다. 이는 피할 수 없는 과정입니다.
- 즉시틀니는 치유 기간 중 점점 느슨해지며, 치유 기간 중 1회 이상의 임시 릴라인(소프트 릴라인)이 필요합니다 — 각 릴라인마다 추가 비용이 발생할 수 있습니다.
- 치유가 완료된 후 약 6~12개월 시점에 경성 릴라인, 리베이스 또는 완전 재제작이 일반적으로 필요합니다. 이 비용은 서면으로 달리 명시되지 않는 한 최초 틀니 비용과 별도로 청구됩니다.
- 발치 후 통증·부기·멍이 있는 기간에는 틀니 사용이 제한될 수 있습니다.

현실적 기대치

다음 사항을 이해하고 수용합니다:

- 틀니는 자연 치아와 동일하게 기능하거나 느껴지거나 보이지 않습니다.
- 장착 후 여러 차례의 조정 내원은 정상적이며 예상되는 과정이지 실패의 징후가 아닙니다.
- 편안함, 유지력, 저작 능력, 심미적 결과의 구체적인 수준을 보장할 수 있는 치과의사는 없습니다 — 이는 개인의 해부학적 구조, 조직 상태, 근육 조절 능력, 환자의 적응력, 가정 관리 및 추적 진료 협조에 크게 좌우되기 때문입니다.
- 틀니 치료의 성공 여부는 적응 기간 중 환자의 인내심, 지속성, 적응 의지에 크게 좌우됩니다.

환자 책임

다음 사항이 환자 본인의 책임임을 이해합니다:

- 전용 틀니 세정제로 매일 틀니를 세척합니다 (일반 치약이나 연마성 세제 사용 금지).
- 야간에는 틀니를 제거하여 구강 조직이 쉴 수 있도록 하고, 변형 방지를 위해 물 또는 틀니 보관액에 담가 보관합니다.
- 예정된 모든 조정 및 추적 진료 예약에 반드시 참석합니다 — 조정을 위한 재내원 미이행은 치료 실패의 주요 원인이며, 이후 추가 비용 없이는 시정할 수 없습니다.
- 틀니를 조심스럽게 취급합니다 — 떨어뜨리거나, 단단한 물체를 씹거나, 부적절한 세정 방법을 사용할 경우 파손에 대한 책임은 환자에게 있습니다.
- 정기 치과 검진(최소 연 1회)을 통해 틀니의 적합도와 남은 치아(있는 경우), 구강 조직, 턱뼈의 상태 — 구강암 선별 포함 — 를 점검합니다.
- 지속적 통증, 욕창, 느슨해짐, 파절, 부적합 등이 발생하면 조직 손상으로 이어지기 전에 즉시 보고합니다.
- 알레르기, 복용 약물(일반의약품·건강보조식품·기호식품 포함), 관련 건강 상태를 포함한 완전하고 정확한 병력을 제공하며, 변경사항이 있을 시 갱신합니다.

재정적 책임 및 추적 관리

- 틀니 비용에는 틀니 제작 및 일정 횟수의 장착 후 조정 내원(통상 장착 후 90일 이내 최대 3회, 서면으로 달리 합의되지 않는 한)이 포함됩니다.
- 해당 기간 이후의 추가 조정, 릴라인, 리베이스, 수리, 재제작, 또는 교체 틀니는 별도 진료이며 추가 비용이 발생합니다.
- 틀니가 장착되어 합리적인 전문적 기준을 충족한 후에는 틀니 비용은 환불되지 않습니다. 왁스 시적에서 승인 후 환자의 심미적 불만족 또는 환자 선호 변경으로 인한 재제작은 최초 비용에 포함되지 않습니다.

- 치료 시작 전 제안된 치료에 대한 서면 비용 견적을 수령하고 이해하였습니다.

최종 동의 — HPOA 준수 선언

다음을 선언하고 확인합니다:

- 제안된 틀니 치료의 성격, 목적, 예상 이점, 중요한 위험, 가능한 합병증, 합리적 대안(치료하지 않는 선택 포함)에 대해 이해할 수 있는 언어로 설명받았습니다.
- 질문할 충분한 기회를 가졌으며, 모든 질문에 만족스러운 답변을 받았습니다.
- 알레르기, 현재 모든 복용 약물, 관련 건강 상태를 포함한 완전하고 정확한 병력을 제공하였으며, 변경사항이 있을 시 갱신하는 것에 동의합니다.
- 틀니의 최종 결과, 편안함, 유지력, 외관, 내구성에 대한 보장이나 보증이 제공되지 않았음을 이해합니다.
- 치료가 완료되기 전 언제든지 서면으로 동의를 철회할 수 있음을 이해합니다.
- 위에 제안된 틀니 치료에 자유 의사로 자발적으로 동의합니다.

이 양식은 2026년 4월 1일부터 시행되는 Health Professions & Occupations Act (HPOA)에 따라 작성되었습니다. 서명은 충분한 설명을 받았고 질문할 기회가 있었으며 자유 의사로 동의함을 의미합니다. 언제든지 서면으로 철회 가능합니다.